Médicaments à arrêter et interactions

Chapitre transversal C — délais d'arrêt, effets sur la fixation, divergences entre fiches

À RETENIR

- **TSM diagnostique** = EE « démaquillée » : β-bloquants et inhibiteurs calciques arrêtés **48 h** (**24–48 h** dans une fiche), dérivés nitrés **24 h** (**12 h** dans une fiche) ; pronostic, viabilité, évaluation du traitement = EE « maquillée » (sous traitement).
- **Test vasodilatateur** : pas de bases xanthiques (café, thé, chocolat, cola, bananes) **12 h** avant ; théophylline arrêtée **5 jours** ; dipyridamole oral arrêté **≥ 12 h** avant l'adénosine **[à vérifier]** *à vérifier : EANM 2015 — au moins 24 h*.
- **MIBG** : labétalol, réserpine, inhibiteurs calciques, antidépresseurs tricycliques, sympathomimétiques — **7–14 j** (labétalol **21 j**) ; délais plus courts dans la fiche thérapie (ICa **24–48 h**, β-stimulants **24 h**).
- **^{131}I** : LT4 **4–6 semaines**, LT3 **2 semaines** (TSH **> 30**) ; aliments iodés **1–2 semaines** ; PDC iodé hydrosoluble **3–4 semaines** (**4–6** dans d'autres fiches) ; amiodarone : mois à années ; ATS **4–10 j** (hyperthyroïdie).
- **Norcholestérol** : spironolactone **6 semaines** ; diurétiques ± β-bloquants **1 semaine** (↓ fixation) ; ICa / IEC **48 h** (↑ fixation) ; MIBG antérieure : **6 semaines**.
- **Rein** : SRD-captopril : IEC **5 j**, diurétiques **3 j** ; DFG : diurétiques **24 h**, chimiothérapie / ATB néphrotoxiques **1 semaine**.
- **Digestif** : breath test — antiacides et anti-H2 **24 h**, IPP **1 semaine** **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel 2 semaines*, ATB **1 mois** ; vidange gastrique — traitements suspendus **≥ 48 h** ; salivaire — anticholinergiques **24 h** ; chromogranine A — IPP **15 j**.
- **TEP-FDG** : insuline → délai **2–3 h** ou **4–6 h** selon la fiche **[à vérifier]** *à vérifier : EANM — ≥ 4 h (insuline rapide), ≥ 6 h (insuline ordinaire)* ; metformine non arrêtée si on évalue l'extension à distance ; corticoïdes et facteurs de croissance à signaler.
- **Analogues de la somatostatine** : action prolongée arrêtée **6 semaines** avant la RIV (relais action courte jusqu'à **J−1**) ; arrêt avant SRS débattu.
- **Autres** : leucocytes marqués — ATB **2 semaines** ; parathyroïdes HPT II — calcimimétiques **2 semaines**, vitamine D **1 semaine** ; RIV ^{89}Sr — biphosphonates **6 j** ; RIV — EPO / facteurs de croissance **2 semaines**.

I. Principes

- **Pourquoi arrêter ?** Quatre mécanismes reviennent d'une fiche à l'autre :
  1. **masquer l'effet recherché** : anti-angineux (effort sous-maximal, ischémie masquée), bases xanthiques (inhibition de l'effet vasodilatateur) ;
  2. **compétition / blocage de la captation** : iode froid (thyroïde), médicaments agissant sur l'uptake des catécholamines (MIBG), analogues froids de la somatostatine, hormonothérapie (FES), LT4 (freine la TSH) ;
  3. **modification de la biodistribution ou du marquage** : insuline et metformine (FDG), corticoïdes, facteurs de croissance (moelle), interférences avec le marquage des GR ;
  4. **faux positifs biologiques** : métanéphrines, chromogranine A, 5-HIAA.
- L'arrêt d'un traitement se décide avec le prescripteur : « sous la responsabilité du cardiologue », « après consultation du médecin traitant », « après accord du médecin ».
- Identifier les médicaments **pris le jour de l'examen** ou **arrêtés intentionnellement** pour l'examen (notamment les anti-angineux) et les noter dans le compte rendu.

EE « maquillée » ou « démaquillée » ?

EE « démaquillée » (après arrêt du traitement)	EE « maquillée » (sous traitement)
• **Diagnostic** de l'insuffisance coronaire. • Évaluation d'un autre territoire non revascularisé (noté « non vascularisé »). • Coronarien connu : évaluation des autres coronaires → arrêt du traitement.	• **Viabilité**, **pronostic**, **évaluation du traitement** (→ pas de stress pharmacologique). • Contre-indication à l'arrêt du traitement. • Pronostic chez un coronarien connu avec revascularisation incomplète : EE sous traitement ; après pontage ou angioplastie, examen sous traitement → épreuve mixte.

> **NB** — Les β-bloquants, inhibiteurs calciques et dérivés nitrés peuvent ne pas être arrêtés chez un coronarien connu (évaluation fonctionnelle, pronostic, viabilité). Écho de stress : β-bloquants ⊖ (à arrêter).

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*

II. Grand tableau : médicament → examen → délai → raison

Médicament (classe)	Examen concerné	Délai d'arrêt	Raison / effet
A. Anti-angineux et cardiovasculaires			
β-bloquants	TSM diagnostique (EE « démaquillée »)	**48 h** (TSM de perfusion et sa suite) ; **24–48 h** (TEMP du myocarde, suite)	Limitent la réponse de la FC → épreuve sous-maximale ; maintenus si EE « maquillée ». EANM 2015 : arrêt idéalement pendant 3 à 5 demi-vies réf.
	Ventriculographie de stress	**24 à 48 h**, après avis du médecin traitant	Limitent la réponse de la fréquence cardiaque
β-bloquants (labétalol)	Scintigraphie MIBG	Labétalol **21 j** ; autres antihypertenseurs **7–14 j** (neuroblastome) ; non précisé (fiches cardiaques)	↓ fixation de la MIBG
β-bloquants ± diurétiques	^{131}I-norcholestérol	**1 semaine** (« 1 semaine – 48 h » dans le tableau récapitulatif)	↓ fixation
β-bloquants, ARA II	SRD sous captopril	Arrêt « si possible », après accord du médecin	—
β-bloquants, méthyldopa, clonidine (+ tricycliques)	Dosage des métanéphrines (phéochromocytome)	**1–2 semaines**	Faux positifs : stimulation de la libération des catécholamines, inhibition de leur recapture ou de leur dégradation
Inhibiteurs calciques	TSM diagnostique	**48 h** (TSM de perfusion et sa suite) ; **24–48 h** (TEMP du myocarde, suite)	Anti-angineux : épreuve sous-maximale, ischémie masquée
	Ventriculographie de stress	**24 à 48 h**	Limitent la réponse de la FC
	Scintigraphie / thérapie MIBG	**24–48 h** (thérapie ^{131}I-MIBG) ; **7–14 j** (neuroblastome) ; non précisé (fiches cardiaques)	Exocytose Ca-dépendante : l'inhibiteur calcique entraîne une **rétention** de la MIBG (↑ fixation). RCP : la nifédipine prolonge la rétention ; une ↓ de captation est aussi rapportée sous inhibiteurs calciques (diltiazem, nifédipine, vérapamil) réf.
	^{131}I-norcholestérol	**48 h** (avec les IEC)	↑ fixation
	Vidange gastrique	**≥ 48 h**	Agissent sur la vidange gastrique
Dérivés nitrés	TSM diagnostique	**24 h** (TSM de perfusion ; TEMP du myocarde, suite) ; **12 h** (TSM de perfusion, suite)	Anti-ischémiques. EANM 2015 : 3 à 5 demi-vies, donc variable selon la forme (courte ou prolongée) réf.
	Viabilité (MIBI / tétrofosmine)	**Au contraire, administrés** : 2 bouffées **5 min** avant l'injection	↑ la sensibilité de détection du myocarde viable

Médicament (classe)	Examen concerné	Délai d'arrêt	Raison / effet
IEC (± ARA II)	SRD sous captopril	**5 jours**	Un IEC au long cours ↓ la sensibilité du test réf.
	^{131}I-norcholestérol	**48 h**	↑ fixation
	MIBG	**7–14 j** (antihypertenseurs)	↑ fixation
Diurétiques	DFG isotopique	**24 h**	—
	SRD sous captopril	**3 jours**	—
Spironolactone	^{131}I-norcholestérol	**6 semaines**	Effet non précisé dans les notes
α-bloquants	Thérapie ^{131}I-MIBG	**15 jours**	Interférence avec la MIBG
Antihypertenseurs centraux, réserpine	MIBG (diagnostic et RIV)	Non précisé	Déplétion des granules / inhibition de l'uptake
Antiarythmiques (amiodarone)	Thérapie ^{131}I-MIBG	**48–72 h** **[à vérifier]** *à vérifier : la demi-vie de l'amiodarone (plusieurs semaines) rend un arrêt de 48–72 h peu cohérent avec la règle d'un arrêt pendant ≈ 4 demi-vies*	Interférence avec la MIBG
	Irathérapie (^{131}I)	Quelques mois à quelques années	Surcharge iodée
Dipyridamole (per os)	Test à l'adénosine	**≥ 12 h** avant la perfusion ; sinon faibles doses d'adénosine **[à vérifier]** *à vérifier : EANM 2015 — arrêt du dipyridamole d'au moins 24 h avant l'adénosine ou le régadénoson*	Inhibe la recapture de l'adénosine → potentialisation
	Scintigraphie aux GR marqués	Non précisé	↓ efficacité du radiomarquage
Héparine	GR marqués (ventriculographie, hémorragie)	Non précisé	Altère la fixation du ^{99m}Tc sur les GR → injecter plus de pyrophosphate
B. Bases xanthiques et sympathomimétiques			
Bases xanthiques alimentaires (café, thé, chocolat, cola, bananes)	Test vasodilatateur (dipyridamole, adénosine)	**12 h**	Inhibition de l'effet vasodilatateur ; café : faux négatif, ↓ réserve coronaire, masque l'↑ du débit. EANM 2015 : caféine ≥ 12 h pour tout patient réf.
Théophylline	Test vasodilatateur	**5 jours**	Antagoniste de l'effet vasodilatateur ; l'aminophylline est d'ailleurs l'antidote. EANM 2015 : médicaments contenant des méthylxanthines arrêtés au moins 5 demi-vies réf.
Sympathomimétiques / β-stimulants (bronchodilatateurs, β-mimétiques)	MIBG (diagnostic et thérapie)	**24 h** (thérapie) ; **7–14 j** (neuroblastome) ; non précisé (fiches cardiaques)	↓ fixation de la MIBG
C. Psychotropes, anticholinergiques, opiacés			
Antidépresseurs tricycliques (amitriptyline)	MIBG (diagnostic et RIV)	**7–14 j** (neuroblastome) ; non précisé (fiches cardiaques, RIV)	Inhibition de l'uptake → ↓ fixation
	Dosage des métanéphrines	**1–2 semaines**	Faux positifs
	Vidange gastrique (antidépresseurs)	**≥ 48 h**	Agissent sur la vidange
Anticholinergiques	Scintigraphie salivaire	**24 h**	↓ sécrétion salivaire réf.
	Vidange gastrique	**≥ 48 h**	Ralentissent la vidange
Opiacés morphiniques ; L-dopa, nicotine	Vidange gastrique	**≥ 48 h** (opiacés)	Retardent la vidange
D. Hormones et endocrinologie			
LT4 (lévothyroxine)	Irathérapie du CDT ; scintigraphie parathyroïdienne (soustraction) ; irathérapie de l'hyperthyroïdie ; scintigraphie thyroïdienne pédiatrique	CDT : **4 à 6 semaines** (4 semaines dans la rubrique « éviction iodée ») ; parathyroïdes : **2 semaines** ; LT4 associée aux ATS : **3 semaines** ; pédiatrie : durée non précisée	Obtenir une TSH **> 30 mUI/L** (stimulation) ; image thyroïdienne de référence
LT3 (Cynomel®)	Irathérapie du CDT	**2 semaines**	Idem (action rapide)
ATS	Irathérapie de l'hyperthyroïdie ; scintigraphie parathyroïdienne (soustraction)	**4 à 10 jours** avant la cure (une fois l'euthyroïdie obtenue) ; **5 jours** si > 40 mg (parathyroïdes)	Inhibent l'organification de l'iode (↓ efficacité de l'^{131}I) réf.

Médicament (classe)	Examen concerné	Délai d'arrêt	Raison / effet
Analogues de la somatostatine	RIV ^{177}Lu-DOTATATE	Action prolongée : **6 semaines** → relais par action courte jusqu'à **1 jour** avant	Saturation des récepteurs
	SRS / TEP ^{68}Ga-DOTA	Arrêt ? **débattu** ; arrêt de la somatostatine avant RIV ++	↓ fixation physiologique et ↑ S/B (meilleure visualisation) *vs* saturation des récepteurs (↓ fixation) ; pas de faux négatif sous analogues ; aucune interférence avec la somatostatine froide
	^{18}F-DOPA	Pas d'arrêt	Pas d'interaction avec le traitement habituel de l'hyperinsulinisme
Glucagon	^{18}F-DOPA (hyperinsulinisme néonatal)	—	Absence de fixation pancréatique (seule interaction rapportée)
Corticoïdes	TEP-FDG	À signaler	Modificateurs de la glycémie (↑ insuline)
	Scintigraphie osseuse	Au long cours : à signaler	Interfèrent avec la fixation du MRP
	SRS	Au long cours : à signaler	Faux positifs
	^{131}I-norcholestérol	À rechercher (traitement anticortisolique)	Interactions
Calcimimétiques ; **vitamine D**	Scintigraphie parathyroïdienne (HPT II^{aire})	**2 semaines** ; **1 semaine**	↓ fixation → faux négatifs
Hormonothérapie (anti-œstrogènes)	TEP ^{18}F-FES	Arrêt (délai non précisé)	Les antagonistes des récepteurs aux œstrogènes (tamoxifène, fulvestrant) bloquent la fixation du FES réf.
THS, contraceptifs oraux	Mammoscintigraphie MIBI	Arrêt (délai non précisé) ; examen à distance des menstruations	Imprégnation hormonale (les menstruations donnent des faux positifs)
E. Glycémie			
Insuline	TEP-FDG	Délai entre l'insuline et le FDG : **2 à 3 h** (fiche TEP-FDG) **[à vérifier]** *à vérifier : EANM — ≥ 4 h après une insuline rapide, ≥ 6 h après une insuline ordinaire* ; **4–6 h** (fiche CCR)	↑ expression membranaire de GLUT4 → ↑ captation musculaire et adipeuse du FDG
Metformine	TEP-FDG	**Jamais arrêtée** si l'on évalue l'extension à distance (et non l'atteinte locale colique)	Fixation colique diffuse
F. Médicaments digestifs			
IPP	Test respiratoire à l'urée	**1 semaine** **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel recommandé 2 semaines*	↓ charge et activité uréasique d'*H. pylori* → faux négatifs réf.
	Dosage de la chromogranine A	**15 jours**	Faux positifs (comme l'insuffisance rénale et la gastrite atrophique)
Antiacides, anti-H2	Test respiratoire à l'urée	**24 h**	Faux négatifs réf. NB : la cimétidine (anti-H2) est au contraire une **prémédication** du Meckel
Ranitidine	GR marqués	Non précisé	↓ efficacité du radiomarquage
Laxatifs ; PDC oral (baryté)	Diverticule de Meckel	Pas de laxatif ; pas de PDC oral **2–3 jours** avant	—
G. Anti-infectieux			
Antibiotiques	Leucocytes marqués	**2 semaines**, notamment en cas de doute	—
	Scintigraphie osseuse (infection)	Vérifier une antibiothérapie	Faux négatif possible
	Test respiratoire à l'urée	**1 mois**	Faux négatifs (bactérie inhibée) réf.
	DFG isotopique (ATB néphrotoxiques)	Signaler ; DFG au moins **1 semaine** après (fiche mémo : 5 j)	Néphrotoxicité
Métronidazole	GR marqués	Non précisé	↓ efficacité du radiomarquage
H. Oncologie, hématologie, immunologie			

Médicament (classe)	Examen concerné	Délai d'arrêt	Raison / effet
Chimiothérapie	TEP-FDG	Délai de **1 mois** (noté « 6 S » : 6 semaines) après la chimiothérapie ou la chirurgie	Fixation inflammatoire ou sidération métabolique post-thérapeutique réf.
	Scintigraphie osseuse	À signaler / arrêter (cancer de la prostate)	Interfère avec la fixation du MRP
	DFG isotopique	DFG avant la chimiothérapie et au moins **1 semaine** après	—
	^{67}Ga	Pas de chimiothérapie récente	—
	RIV ^{223}Ra ; palliation osseuse	Pas de chimiothérapie ni de RTE dans les **6–8 semaines** (^{223}Ra) ; intervalle de **4–12 semaines** (palliation)	Toxicité médullaire cumulée réf.
	GR marqués	Non précisé	↓ efficacité du radiomarquage
Radiothérapie	TEP-FDG	**4–6 mois** (2–3 mois) après la radiothérapie	Inflammation post-radique (faux positifs) réf.
	Mammoscintigraphie ; SRS ; ^{67}Ga	**2–3 mois** (mammoscintigraphie) ; RT récente à signaler	Fixation post-radique possible (SRS)
Facteurs de croissance (G-CSF), EPO	TEP-FDG ; SO ; RIV	À signaler (FDG, SO) ; arrêt **2 semaines** avant la RIV	Réactivation de la moelle osseuse (FDG)
Ciclosporine, digoxine	GR marqués	Non précisé	↓ efficacité du radiomarquage
Acétate d'abiratérone et/ou prednisone	RIV ^{223}Ra	Association contre-indiquée	CI absolue de l'association (excès de fractures et de décès) réf.
I. Os			
Biphosphonates, dénosumab	Scintigraphie osseuse	À signaler (arrêt en cas de cancer de la prostate)	Interfèrent avec la fixation du MRP
	RIV ^{89}Sr	Arrêt **6 jours** avant	—
	RIV ^{223}Ra	**Au contraire, associés**	Risque fracturaire
AINS	Scintigraphie osseuse	À signaler	Interfèrent avec la fixation du MRP
J. Iode, produits de contraste et métaux			
Aliments riches en iode (poisson, fruits de mer, sel iodé)	Irathérapie	**1 à 2 semaines** (CDT) ; **15 jours** (hyperthyroïdie)	Surcharge iodée
Médicaments et topiques iodés (Bétadine…)	Irathérapie	**1 à 2 semaines**	Surcharge iodée
PDC iodés	Irathérapie ; scintigraphie parathyroïdienne (soustraction) ; scintigraphie thyroïdienne pédiatrique	Hydrosoluble : **3 à 4 semaines** (CDT) ; **4–6 semaines** (hyperthyroïdie, parathyroïdes) ; liposoluble (cholécystographie) **3 mois** ; huileux (bronchographie) **6–12 mois** ; myélographie **2 à 10 ans**	Surcharge iodée ; iodurie des 24 h si doute
PDC iodés	GR marqués	Non précisé	↓ efficacité du radiomarquage
Gadolinium ; **sels de fer**	^{67}Ga	Pas d'IRM injectée dans les **24 h** ; pas de fer récent	—

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *L'hyperparathyroïdie*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Phéochromocytome et paragangliome*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *Tumeurs neuroendocrines*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Exploration isotopique des hémorragies digestives*, *Diverticule de Meckel*, *Exploration de la motricité digestive*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *La scintigraphie salivaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*

III. Délais divergents entre fiches (côte à côte)

Élément	Valeur A (fiche)	Valeur B (fiche)	Commentaire / référence
β-bloquants avant TSM diagnostique	**48 h** (TSM de perfusion et sa suite)	**24–48 h** (TEMP du myocarde, suite ; ventriculographie)	EANM 2015 : 3 à 5 demi-vies réf.
Inhibiteurs calciques avant TSM	**48 h** (TSM de perfusion et sa suite)	**24–48 h** (TEMP du myocarde, suite ; ventriculographie)	Idem réf.
Dérivés nitrés avant TSM	**24 h** (TSM de perfusion ; TEMP du myocarde, suite)	**12 h** (TSM de perfusion, suite : EE « démaquillée »)	Idem : dépend de la forme galénique réf.
Dipyridamole oral avant adénosine	**≥ 12 h** (TEMP du myocarde, suite)	—	**[à vérifier]** *à vérifier : EANM 2015 — au moins 24 h*
Insuline → injection de FDG	**2–3 h** (TEP-FDG en cancérologie)	**4–6 h** (TEP-FDG et CCR)	**[à vérifier]** *à vérifier : EANM — ≥ 4 h (insuline rapide), ≥ 6 h (insuline ordinaire) ; la valeur de 2–3 h est trop courte*
Inhibiteurs calciques avant MIBG	**24–48 h** (thérapie MIBG)	**7–14 j** (neuroblastome)	RCP ^{123}I-MIBG : arrêt pendant ≈ 4 demi-vies biologiques réf.
Sympathomimétiques avant MIBG	**24 h** (thérapie MIBG)	**7–14 j** (neuroblastome)	—
Labétalol avant MIBG	**21 j** (neuroblastome)	Non précisé (MIBG cardiaque)	—
Amiodarone	**48–72 h** (thérapie MIBG)	Quelques mois à années (^{131}I : surcharge iodée)	**[à vérifier]** *à vérifier : délai MIBG court au regard de la demi-vie de l'amiodarone*
PDC iodé hydrosoluble avant ^{131}I	**3–4 semaines** (CDT)	**4–6 semaines** (hyperthyroïdie ; parathyroïdes)	—
Aliments iodés avant ^{131}I	**1–2 semaines** (CDT)	**15 jours** (hyperthyroïdie)	Concordants
LT4	**4–6 semaines** (sevrage du CDT ; 4 semaines dans la rubrique « éviction iodée »)	**2 semaines** (parathyroïdes) ; **3 semaines** (LT4 associée aux ATS)	Contextes différents (stimulation TSH vs image thyroïdienne)
ATS	**4–10 jours** (irathérapie de l'hyperthyroïdie)	**5 jours** si > 40 mg (parathyroïdes)	—
IPP	**1 semaine** (breath test)	**15 jours** (chromogranine A)	**[à vérifier]** *à vérifier : breath test — délai usuel 2 semaines*
Chimiothérapie / ATB néphrotoxiques avant DFG	**1 semaine** (texte ; SRD-captopril)	5 j (fiche mémo)	—
FDG après chimiothérapie / radiothérapie	**1 mois** (noté « 6 S » : 6 semaines) / **4–6 mois**	Radiothérapie : **2–3 mois** (entre parenthèses dans la même fiche)	Lymphomes : TEP de fin de traitement ≥ 3 semaines (idéalement 6–8) après la chimiothérapie, 8–12 semaines après la radiothérapie réf.
Mammoscintigraphie après chirurgie	**2–3 mois** (sein ; additif sein)	**2 mois** (tableau des activités)	—
Analogues de la somatostatine	Arrêt « débattu » avant la SRS	**6 semaines** (action prolongée) / **J–1** (action courte) avant la RIV	Imagerie vs thérapie

Sources : *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite)*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Scintigraphie cardiaque à la MIBG*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *L'hyperparathyroïdie*, *Test respiratoire à l'urée (« breath test »)*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tumeurs neuroendocrines*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*

IV. À ne pas confondre : médicaments administrés volontairement

Médicament	Examen	Modalités	But
Dérivés nitrés	TSM de viabilité	2 bouffées **5 min** avant l'injection	↑ sensibilité

Médicament	Examen	Modalités	But
Héparine non fractionnée	TEP-FDG cardiaque	**50 UI/kg** avant le FDG	Améliore la suppression du métabolisme glucidique
Furosémide	^{18}F-choline ; FDG (masse pelvienne) ; SRD (test d'hyperdiurèse)	**20 mg IV** ; SRD **1 mg/kg** (max 20 mg)	↓ activité vésicale ; obstacle vs simple dilatation (**85 %** des cas)
Carbidopa	^{18}F-DOPA	**100–200 mg** 1 h avant	↑ biodisponibilité, ↓ fixation pancréatique
Cimétidine, glucagon, pentagastrine	Diverticule de Meckel	Cimétidine per os 48 h ou IV 1 h avant	↑ Se (**85 % → 92 %**) et Sp
KI, Lugol, perchlorate	MIBG, norcholestérol, ioflupane	Voir la fiche « Préparation du patient »	Blocage thyroïdien
Dexaméthasone, colestyramine, laxatifs	^{131}I-norcholestérol	2 mg/j J−2 → fin ; colestyramine après 48 h ; Duphalac J−2 → fin	Freinage ; cycle entérohépatique ; côlon
Acides aminés (arginine, lysine)	RIV aux analogues de la somatostatine	**25 g** en 4–6 h, débutés 30–60 min avant	Néphroprotection
Corticoïdes	Cure d'^{131}I ; hyperthyroïdie auto-immune	**0,5–1 mg/kg/j**	Prévenir la compression / l'ophtalmopathie
β-bloquant ou myorelaxant	TEP-FDG	—	Patient anxieux
Aminophylline ; esmolol ; diltiazem ; atropine	Stress pharmacologique	**60–120 mg** IVL ; **50–100 mg** ; **25 mg** ; **0,5–1 mg**	Antidotes (vasodilatateurs ; dobutamine) ; atropine si FC insuffisante sous dobutamine

> **Moyen mnémotechnique** — « **48 – 24 – 12 – 5** » pour la TSM : β-bloquants et inhibiteurs calciques **48 h**, dérivés nitrés **24 h**, bases xanthiques **12 h**, théophylline **5 jours** (valeurs majoritaires des notes).

Sources : *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *La sarcoïdose cardiaque*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale*, *Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Diverticule de Meckel*, *Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Délais d'arrêt des anti-angineux avant une TSM diagnostique ?	β-bloquants et inhibiteurs calciques 48 h (24–48 h dans une fiche) ; dérivés nitrés 24 h (12 h dans une fiche).
2. Quand garde-t-on le traitement anti-angineux (EE « maquillée ») ?	Viabilité, pronostic, évaluation du traitement, contre-indication à l'arrêt.
3. Que faut-il éviter avant un test au dipyridamole ou à l'adénosine ?	Bases xanthiques (café, thé, chocolat, cola, bananes) 12 h ; théophylline 5 j ; dipyridamole oral ≥ 12 h avant l'adénosine **[à vérifier]** *à vérifier : EANM 2015 — au moins 24 h*.
4. Citez les classes interférant avec la MIBG.	Labétalol et antihypertenseurs, réserpine, inhibiteurs calciques, antidépresseurs tricycliques, sympathomimétiques (7–14 j ; labétalol 21 j).
5. Effet des inhibiteurs calciques sur la MIBG ?	Rétention de la MIBG (exocytose Ca-dépendante) → ↑ fixation.
6. Délais d'arrêt de la LT4 et de la LT3 avant irathérapie ?	LT4 4–6 semaines, LT3 2 semaines ; objectif TSH > 30 mUI/L.
7. Délai après un PDC iodé hydrosoluble avant une cure d'^{131}I ?	3–4 semaines (CDT) ; 4–6 semaines (hyperthyroïdie, parathyroïdes).
8. Interférences avec le ^{131}I-norcholestérol ?	Spironolactone 6 semaines ; diurétiques ± β-bloquants 1 semaine (↓ F) ; ICa / IEC 48 h (↑ F) ; MIBG antérieure 6 semaines.
9. Arrêts avant une SRD sous captopril ?	IEC 5 j, diurétiques 3 j, β-bloquants et ARA II si possible ; régime normosodé 48–72 h.
10. Arrêts avant un test respiratoire à l'urée ^{14}C ?	Antiacides et anti-H2 24 h, IPP 1 semaine **[à vérifier]** *à vérifier : délai usuel 2 semaines*, ATB 1 mois ; jeûne ≥ 6 h.
11. Insuline et metformine avant une TEP-FDG ?	Insuline : délai 2–3 h ou 4–6 h selon la fiche (GLUT4) **[à vérifier]** *à vérifier : EANM — ≥ 4 h (insuline rapide), ≥ 6 h (insuline ordinaire)* ; metformine non arrêtée si l'on évalue l'extension à distance (fixation colique).
12. Analogues de la somatostatine avant ^{177}Lu-DOTATATE ?	Action prolongée arrêtée 6 semaines avant, relais par action courte jusqu'à J−1.